

약제 영양급여의 적정성 평가결과

vinorelbine tartrate (as vinorelbine 20mg, 30mg)

(나벨빈연질캡슐20, 30밀리그램, 부광약품(주))

☐ **제형, 성분·함량:**

- 1캡슐 중 vinorelbine 20mg, 30mg

☐ **효능 효과:**

- 비소세포폐암, 진행성 유방암

☐ **약제급여평가위원회 심의일**

2020년 제4차 약제급여평가위원회: 2020년 4월 8일~9일

- 암질환심의위원회 심의일: 2019년 10월 16일¹⁾

※ 약제급여평가위원회 평가결과 중 해당 제약회사의 영업상 비밀에 해당하는 내용(신청자의견, 신청가격 및 이와 관련된 투약비용, 재정영향 금액 등)은 공개 대상에서 제외하였습니다.

가. 평가 결과

- 평가금액 이하 수용시 급여의 적정성이 있음
- 신청품은 “비소세포폐암 및 진행성 유방암”에 허가받은 약제로, 대체약제 대비 효과가 열등하다고 보기 어려우나 투약비용이 대체약제보다 고가로, 이에 상응하는 비용효과성이 불분명하여 비급여함.
- 단, 제약사가 대체약제의 가중평균가로 환산된 금액(20mg: ■■■원/캡슐, 30mg: ■■■원/캡슐) 이하를 수용할 경우 급여의 적정성이 있으며, 약가협상생략기준금액(20mg: ■■■원/캡슐, 30mg: ■■■원/캡슐)²⁾ 이하를 수용할 경우 상한금액 협상절차를 생략함.

나. 평가 내용

- 진료상 필수 여부
 - 신청품은 “비소세포폐암 및 진행성 유방암”에 허가 받은 약제로, 현재 해당 적응증에 사용가능한 약제로 동일 성분 vinorelbine 주사제가 등재되어 있는 점 등을 고려 시, 약제의 요양급여대상여부 등의 평가기준 및 절차 등에 관한 규정 제6조(진료상 반드시 필요하다고 판단되는 약제)에 해당하지 않음.
- 임상적 유용성
 - 신청품은 ‘비소세포폐암 및 진행성 유방암’에 허가된 1군 항암제³⁾로, 기존의 동일 성분(vinorelbine) 주사제를 경구 제형으로 복용하는 개량신약임.

<비소세포폐암>

- 신청품 성분(비노렐빈)은 교과서⁴⁾⁵⁾⁶⁾ 및 임상진료지침⁷⁾⁸⁾⁹⁾¹⁰⁾에서 비소세포폐암 환자의 선행화학요법 및 수술 후 보조요법, 진행성/전이성 환자의 전신요법에 사용하도록 권고되고 있으며, 다만 제형에 따른 별도의 언급은 하고 있지 않음¹¹⁾.
- [Jassem J]¹²⁾ 이전에 항암화학요법 치료를 받은 경험이 없는 국소진행성(3B기) 또는 전이성(4기) 비소세포폐암 환자(n=115)¹³⁾를 대상으로 한 다기관, 무작위배정(2:1), 공개라벨, 동일성분(vinorelbine) 주사제 대조 신청품의 2상 임상시험 결과¹⁴⁾, 1차 평가지표인 전체반응률(ORR, overall response rate)은 대조군(VNR iv, n=38) 12%(95% CI, 1-23%) 대비 신청품군(VNR po, n=77)에서 14%(95% CI, 6-23%)로 유사했음.
 - 2차 평가지표인 무진행생존기간(PFS, progression free survival) 중앙값은 대조군(VNR iv, n=38) 2.1개월 대비 신청품군(VNR po, n=77)에서 3.2개월로 유사했으며, 전체생존기간(OS, overall survival) 중앙값 또한 대조군(VNR iv, n=38) 7.9개월 대

비 신청품군(VNR po, n=77)에서 9.3개월로 유사했음.

- 두 군에서 가장 흔하게 발생한 혈액학적 독성은 호중구 감소증이었으며, 신청품군에서 가장 흔하게 발생한 비혈액학적 독성은 구역, 구토, 설사 및 식욕부진이었음.
- **[GLOB3]**¹⁵⁾ 이전에 항암화학요법 및 면역 치료를 받은 경험이 없는 국소진행성(3B기) 또는 전이성(4기) 비소세포폐암 환자(n=381)¹⁶⁾를 대상으로 한 다국가, 다기관, 무작위배정, 공개라벨, 도세탁셀/시스플라틴 병용요법 대조 비노렐빈(iv, po 교차투여)/시스플라틴 병용요법의 3상 임상시험 결과¹⁷⁾, 1차 평가지표인 치료 실패시까지의 시간(TTF, time to treatment failure)의 중앙값은 대조군(DCT+CDDP, n=191) 4.11개월(95% CI, 3.45-4.50) 대비 신청품군(VNR+CDDP, n=190)에서 3.22개월(95% CI, 2.96-4.24)로 유사했음(HR=0.872; 95% CI, 0.710-1.072; p=0.20).
- 2차 평가지표인 무진행생존기간(PFS, progression free survival) 중앙값은 대조군(DCT+CDDP, n=191) 5.1개월(95% CI, 4.34-6.14) 대비 신청품군(VNR+CDDP, n=190)에서 4.9개월(95% CI, 4.44-5.95)로 유사했으며(p=0.99), 전체생존기간(OS, overall survival) 중앙값 또한 대조군(DCT+CDDP, n=191) 9.8개월(95% CI, 8.80-11.5) 대비 신청품군(VNR+CDDP, n=190)에서 9.9개월(95% CI, 8.41-11.6)로 유사했음(p=0.58).

<진행성 유방암>

- 신청품 성분(비노렐빈)은 교과서¹⁸⁾¹⁹⁾²⁰⁾ 및 임상진료지침²¹⁾²²⁾²³⁾에서 진행성 유방암 환자의 전신요법에 사용하도록 권고되고 있으며, 다만 제형에 따른 별도의 언급은 하고 있지 않음²⁴⁾.
- **[Strada MR]**²⁵⁾ 전이성 질환에 대해 이전에 항암화학요법 치료를 받은 경험이 없는 HER2 음성 전이성 유방암 환자(n=88)²⁶⁾를 대상으로 한 다기관, 공개라벨, 비노렐빈(iv)/카페시타빈 병용요법 대조 비노렐빈(po)/카페시타빈 병용요법의 2상 임상시험 결과²⁷⁾, 1차 평가지표인 전체반응률(ORR, overall response rate)은 대조군(VNR iv+CAP, n=42) 73.2%(95% CI, 56.4-82.8) 대비 신청품군(VNR po+CAP, n=46)에서 76.0%(95% CI, 62.0-86.0)로 유사했음.
- 2차 평가지표인 무진행생존기간(PFS, progression free survival) 중앙값은 대조군(VNR iv+CAP, n=42) 8.2개월(95% CI, 7.5-8.8; 범위 6-14개월) 대비 신청품군(VNR po+CAP, n=46)에서 8.8개월(95% CI, 8.4-9.1; 범위 8-21개월)로 유사했으며, 전체생존기간(OS, overall survival) 중앙값 또한 대조군(VNR iv+CAP, n=42) 32.4개월(95% CI, 31.1-36.6; 범위 17-36개월) 대비 신청품군(VNR po+CAP, n=46)에서 34.3개월(95% CI, 28.1-38.0; 범위 14-39개월)로 유사했음.
- 가장 심한 독성은 두 연구에서 유의하게 다르지 않았음. 호중구감소증은 두 연구에서 주요 혈액학적 독성이었음 [3/4등급: 주사제군 11명 (26.1%), 경구제군 8명 (17.3%)].

- [Campone M]²⁸⁾ 전이성 질환에 대해 이전에 항암화학요법 치료를 받은 경험이 없는 HER2 음성 전이성 유방암 환자(n=138)²⁹⁾를 대상으로 한 다기관, 무작위 배정, 공개라벨, 도세탁셀/카페시타빈 병용요법, 비노렐빈(po)/카페시타빈 병용요법 및 비노렐빈(po)↔카페시타빈 순차요법 3개 요법을 비교한 2상 임상시험 결과³⁰⁾, 1차 평가지표인 전체 조절률(DCR, disease control rate)은 대조군(DCT+CAP, n=48)에서 70.8%(95% CI, 55.9-83.1), 신청품군1(VNR+CAP, n=44)에서 70.5%(95% CI, 54.8-83.2), 신청품군2(VNR↔CAP, n=46)에서 37.0%(95% CI, 23.2-52.5)이었음.
 - 2차 평가지표인 무진행생존기간(PFS, progression free survival) 중앙값은 대조군(DCT+CAP, n=48)에서 8.9개월(95% CI, 7.2-12.0), 신청품군1(VNR+CAP, n=44)에서 7.2개월(95% CI, 5.3-8.9), 신청품군2(VNR↔CAP, n=46)에서 3.4개월(95% CI, 2.6-5.6)이었으며, 전체생존기간(OS, overall survival) 중앙값은 대조군(DCT+CAP, n=48)에서 24.2개월(95% CI, 14.2-38.5), 신청품군1(VNR+CAP, n=44)에서 22.2개월(95% CI, 18.8-29.9), 신청품군2(VNR↔CAP, n=46)에서 19.4개월(95% CI, 12.5-35.4)이었음.
- [Cinieri S]³¹⁾ 전이성 질환에 대해 이전에 항암화학요법 치료를 받은 경험이 없는 HER2 음성 전이성 유방암 환자(n=149)³²⁾를 대상으로 한 다국가, 다기관, 무작위 배정, 공개라벨, 젬시타빈/파클리탁셀 병용요법, 젬시타빈/도세탁셀 병용요법 및 비노렐빈(po)/카페시타빈 병용요법 3개 요법을 비교한 2상 임상시험 결과³³⁾, 1차 평가지표인 전체 조절률(DCR, disease control rate)은 대조군1(GEM+PAC, n=50)에서 78%(95% CI, 64-88), 대조군2(GEM+DCT, n=50)에서 80%(95% CI, 66-90), 신청품군(VNR+CAP, n=49)에서 73%(95% CI, 59-85)이었음.
 - 2차 평가지표인 무진행생존기간(PFS, progression free survival) 중앙값은 대조군1(GEM+PAC, n=50)에서 9.0개월(95% CI, 7.0-11.2), 대조군2(GEM+DCT, n=50)에서 11.4개월(95% CI, 7.6-13.8), 신청품군(VNR+CAP, n=49)에서 7.6개월(95% CI, 6.0-11.0)이었으며, 전체생존기간(OS, overall survival) 중앙값은 대조군1(GEM+PAC, n=50)에서 29.6개월(95% CI, 21.2-42.2), 대조군2(GEM+DCT, n=50)에서 31.0개월(95% CI, 24.2-40.0), 신청품군(VNR+CAP, n=49)에서 30.2개월(95% CI, 24.0-42.2)이었음.
- 관련학회³⁴⁾에 따르면, 비노렐빈은 타 항암제 대비 유사한 치료효과와 낮은 grade 3-4 부작용에도 불구하고, 수포제(vesicant)에 해당하는 약물로 주사제로 투여할 때 조직손상과 괴사를 초래할 수 있으며, 혈관 외 유출시 통증, 홍반, 부종 등을 호소하는 경우가 있음. 반면 신청품은 경구제로서 이러한 주사제 투여로 인한 합병증 우려를 줄일 수 있고, 주사시간 및 정맥세척 과정이 생략되어 환자 및 의료진의 소요시간을 감소시킬 수 있다는 의견을 제시함.

○ 비용 효과성

- 신청품의 허가사항, 가이드라인 및 급여기준 등을 고려하여 vinorelbine 주사제를 대체 약제로 선정함.
- 신청품의 투여기간(1주기, 3주)당 소요비용은 ■■■■■원으로 대체약제의 가중 소요비용인 ■■■■■원 보다 고가임.
 - 대체약제 가중평균가로 환산한 신청품의 단위비용은 (20mg)■■■■■원/캡슐, (30mg) ■■■■■원/캡슐임.
 - 신청품의 약가협상생략기준금액³⁵⁾은 (20mg)■■■■■원/캡슐, (30mg)■■■■■원/캡슐임.
- “비소세포폐암 및 진행성 유방암 환자”를 대상으로 수행한 비노렐빈 주사제 대비 신청품의 비용 최소화 분석 결과, 신청품은 비교약제 대비 임상적 유용성이 비열등하다는 것을 입증할 근거가 부족한 바, 경제성평가 자료(비용최소화 분석) 제출 대상에 해당하지 않음³⁶⁾.
 - (비열등성 검정 방법론의 수용가능성 관련) 제약사에서 제시한 비열등성 검정방법론 digitizing은 약제의 요양급여 여부를 결정하기 위한 의사결정 과정에서 해당 방법론 및 결과를 근거로서 채택하기에 방법론에 대한 불확실성이 큰 바, 해당 주장 및 결과값을 수용하기 어려움³⁷⁾.

○ 재정 영향³⁸⁾

<비소세포폐암>

(가) 신청약가 기준

- 제약사 제시 예상 사용량³⁹⁾을 기준으로 신청품의 도입 후 절대재정소요금액⁴⁰⁾은 1차년도 약 ■■■■■원, 3차년도 약 ■■■■■원이 되고, 대체약제의 대체로 재정소요금액⁴¹⁾은 1차년도 약 ■■■■■원, 3차년도 약 ■■■■■원 증가할 것으로 예상됨.

(나) 대체약제 가중평균가로 환산된 금액 기준

- 제약사 제시 예상 사용량을 기준으로 신청품의 도입 후 절대재정소요금액은 1차년도 약 ■■■■■원, 3차년도 약 ■■■■■원으로, 대체 약제의 대체로 인한 재정 증분은 없음.

<진행성 유방암>

(가) 신청약가 기준

- 제약사 제시 예상 사용량⁴²⁾을 기준으로 신청품의 도입 후 절대재정소요금액⁴³⁾은 1차년도 약 ■■■■■원, 3차년도 약 ■■■■■원이 되고, 대체약제의 대체로 재정소요금액⁴⁴⁾은 1차년도 약 ■■■■■원, 3차년도 약 ■■■■■원 증가할 것으로 예상됨.

(나) 대체약제 가중평균가로 환산된 금액 기준

- 제약사 제시 예상 사용량을 기준으로 신청품의 도입 후 절대재정소요금액은 1차년도 약 ■■■원, 3차년도 약 ■■■원으로, 대체 약제의 대체로 인한 재정 증분은 없음.

- 제약사는 비노렐빈 주사제의 연간 판매량에서 적응증별 사용량 산출이 불가능함을 이유로 비소세포폐암과 진행성 유방암의 환자수를 동일한 비율(1:1)로 가정하였으나, 이는 실무 검토시 추계한 비율(비소세포폐암:진행성 유방암 = 4.5:1)과 차이가 매우 큼. 따라서 제약사 제시 예상 사용량을 기준으로 산출한 절대재정소요금액은 불확실성이 매우 큼.

※ 신청품의 대상 환자수 및 투여기간, 시장점유율 등에 따라 재정영향은 변동될 수 있음.

○ 제외국 약가집 수재 현황

- 신청품은 A7 국가 중 프랑스, 독일, 이탈리아, 스위스, 영국 등 5개 약가집에 수재되어 있음.

References

- 1) [REDACTED]
- 2) [REDACTED]
- 3) 1군 항암제의 경우 허가사항 범위 내에서 진료의사의 의학적 판단 및 환자의 증상 등에 따라 필요·적절하게 투여시 영양급여를 인정함 (암환자에게 처방·투여하는 약제에 대한 영양급여의 적용기준 및 방법에 관한 세부사항. 2019. 건강보험심사평가원).
- 4) DeVita, Hellman, and Rosenberg's Cancer: Principles & Practice of Oncology, 10e, 2015. >Chapter 41: Non-Small Cell Lung Cancer
- 5) Harrison's Principles of Internal Medicine, 20e, 2018. >Chapter 74: Neoplasms of the Lung
- 6) The MD Anderson Manual of Medical Oncology, 3e, 2016. >Chapter 18: Non-Small Cell Lung Cancer
- 7) 비소세포폐암 진료지침, 2011. 대한폐암학회.
- 8) NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology(NCCN Guidelines). Non-Small Cell Lung Cancer. Version 3. 2020 - February 11, 2020.
- 9) ESMO. CLINICAL PRACTICE GUIDELINES. Early and locally advanced non-small-cell lung cancer (NSCLC): ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up. Annals of Oncology 28 (Supplement 4): iv1 - iv21, 2017.
- 10) ESMO. CLINICAL PRACTICE GUIDELINES. Metastatic non-small cell lung cancer: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up. Annals of Oncology 29 (Supplement 4): iv192 - iv237, 2018.
- 11) 단, 미국(FDA)의 경우 비노렐빈 경구제에 대한 허가가 없으며 이에 따라 NCCN 가이드라인에서도 경구제에 대한 언급은 없음.
- 12) A multicenter randomized phase II study of oral vs. intravenous vinorelbine in advanced non-small-cell lung cancer patients. Jassem J, et al. Ann Oncol. 2001 Oct;12(10):1375-81.
- 13) Karnofsky PS(KPS) 수행상태 ≥ 80 , 골수기능(절대 호중구 수 $\geq 2000/\text{ml}$, 혈소판 수 $\geq 100,000/\text{ml}$ 및 헤모글로빈 수치 $\geq 11\text{g/dl}$), 간 및 신기능($\text{AST, ALT} \leq 2.5 \times \text{ULN}$, 총 빌리루빈 $\leq 1.5 \times \text{ULN}$, 알칼리인산분해효소 $\leq 5 \times \text{ULN}$, 혈청 크레아티닌 $\leq 1.5 \times \text{ULN}$)이 적합한 환자가 대상 환자로 선정되었으며, 뇌전이가 있거나 동시 방사선 요법을 받고 있는 환자는 제외되었음.
- 14) 약물 투여횟수의 중앙값은 신청품군(VNR po)에서 9회, 대조군(VNR iv)에서 10회였으며, 평균 용량강도는 신청품군(VNR po)에서 $62.5\text{mg}/\text{m}^2/\text{주}$ (계획용량의 89%)였고, 대조군(VNR iv)에서 $22.7\text{mg}/\text{m}^2/\text{주}$ (계획용량의 76%)였음.
- 15) Global Lung Oncology Branch trial 3 (GLOB3): final results of a randomised multinational phase III study alternating oral and i.v. vinorelbine plus cisplatin versus docetaxel plus cisplatin as first-line treatment of advanced non-small-cell lung cancer. Tan EH, et al. Ann Oncol. 2009 Jul;20(7):1249-56.
- 16) Karnofsky PS(KPS) 수행상태 ≥ 80 , 골수(호중구수 $\geq 2.0 \times 10^9/\text{l}$, 혈소판수 $\geq 100 \times 10^9/\text{l}$, 헤모글로빈 수치 $> 11\text{g/dl}$ 또는 6.8mmol/l), 간 및 신기능(총 빌리루빈 $\leq 1 \times \text{ULN}$, 아미노전이효소 $< 2.5 \times$ 정상 상

한치, 알칼리인산분해효소 $\leq 5 \times \text{ULN}$, 크레아티닌 $\leq \text{ULN}$, 크레아티닌 청소율 $\geq 60 \text{ml/min}$)이 적합한 환자가 대상 환자로 선정되었음.

- 17) 신청품군(VNR+CDDP)의 경우, 1주기 중 Day1에는 vinorelbine 주사제(30mg/m^2 , 첫1주기: 25mg/m^2)를, Day8에는 vinorelbine 경구제(80mg/m^2 , 첫1주기: 60mg/m^2)를 교차 투여함. 약물 투여는 신청품군(VNR+CDDP)의 85명, 대조군(DCT+CDDP)의 98명에서 계획된 6주기동안 투여되었고, 각각 평균 4.2주기 및 4.4주기동안 투여받았음. 또한 두 군에서 각각 124명 및 129명이 4주기 투여를 완료하였음.
- 18) DeVita, Hellman, and Rosenberg's Cancer: Principles & Practice of Oncology, 10e, 2015. >Chapter 79: Malignant Tumors of the Breast
- 19) Harrison's Principles of Internal Medicine, 20e, 2018. >Chapter 75: Breast Cancer
- 20) The MD Anderson Manual of Medical Oncology, 3e, 2016. >Chapter 28: Metastatic Breast Cancer
- 21) 2019 제 8차 한국유방암 진료권고안. 2019.4. 한국유방암학회
- 22) NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology(NCCN Guidelines). Breast Cancer. Version 2. 2020 - February 05, 2020.
- 23) ESMO. 3rd ESO - ESMO International Consensus Guidelines for Advanced Breast Cancer (ABC 3). Ann Oncol. 2017 Jan 1;28(1):16-33.
- 24) 단, 미국(FDA)의 경우 비노렐빈 경구제에 대한 허가가 없으며 이에 따라 NCCN 가이드라인에서도 경구제에 대한 언급은 없음.
- 25) Intravenous or oral vinorelbine plus capecitabine as first-line treatment in HER2- metastatic breast cancer: joint analysis of 2 consecutive prospective phase II trials. Strada MR, et al. Clin Breast Cancer. 2012 Feb;12(1):30-9.
- 26) 전이성 유방암에 대한 항암화학요법 사용이력이 없으면서, ECOG 수행능력 2 이하, 골수기능(절대 호중구수 $1500/\text{dL}$, 헤모글로빈 수치 9.5g/dL , 혈소판수 $100,000/\text{dL}$), 간기능(혈청 빌리루빈 수치 2.0mg/dL , $2 \times \text{ULN}$ 이하의 ALT, AST, ALP 수치), 신기능(혈청 크레아티닌 수치 1.1mg/dL) 이 적합한 환자가 대상 환자로 선정되었으며, 중추신경계 장애, 뇌전이, 연수막 침윤의 임상적 증후가 있는 경우, 근치적으로 절제된 비흑색종 피부암 및 자궁경부암을 제외한 타 암종에 대한 이력이 있는 환자는 제외되었음.
- 27) 비노렐빈/카페시타빈 병용요법(VNR+CAP)의 효과 및 안전성을 평가하기 위하여, 비노렐빈의 투여경로(iv, po)만 다르게 한 2건의 전향적 2상 임상시험을 연속적으로 수행하였으며, 본 논문은 두 시험의 최종결과를 결합 분석하여 보고함. 약물 투여주기의 중앙값은 신청품군(VNR po+CAP)에서 8주기(범위 6-10), 대조군(VNR iv+CAP)에서 6주기(범위 4-8)이었음.
- 28) A three-arm randomized phase II study of oral vinorelbine plus capecitabine versus oral vinorelbine and capecitabine in sequence versus docetaxel plus capecitabine in patients with metastatic breast cancer previously treated with anthracyclines. Campone M, et al. Breast J. 2013 May-Jun;19(3):240-9.
- 29) 전이성 유방암에 대한 항암화학요법 사용이력이 없으면서, Karnofsky 수행능력(KPS)이 70점 이상, 절대호중구 수 $\geq 2,000/\mu\text{L}$, 헤모글로빈 수치 $\geq 10 \text{g/dL}$, 혈소판 수 $\geq 100,000/\mu\text{L}$, AST와 ALT $\leq 2.5 \times \text{ULN}$, 알칼리인산분해효소 $\leq 5 \times \text{ULN}$, 이전에 선행화학요법(neoadjuvant) 또는 수술후보조요법(adjuvant)으로 안트라사이클린(anthracycline) 치료를 받은 환자가 대상 환자로 선정되었으며, 이전에 플루오로피리미딘(fluoropyrimidine) 치료에 중증의 예상치 못한 반응을 보였거나 5-플루오로우라실(5-FU)에 과민반응이 있는 경우, 뇌전이 및 2등급 이상의 진행성 신경병증이 있는 환

자는 제외되었음.

- 30) 약물 투여주기의 중앙값은 신청품군1(VNR+CAP)에서 8주기(범위 1-38), 신청품군2(VNR↔CAP)에서 4주기(범위 1-25), 대조군(DCT+CAP)에서 6주기(범위 1-23)이었음.
- 31) Final Results of the Randomized Phase II NorCap-CA223 Trial Comparing First-Line All-Oral Versus Taxane-Based Chemotherapy for HER2-Negative Metastatic Breast Cancer. Cinieri S, et al. Clin Breast Cancer. 2017 Apr;17(2):91-99.e1.
- 32) 전이성 유방암에 대한 항암화학요법 사용이력이 없으면서, Karnofsky 수행능력(KPS)이 70점 이상, 적합한 골수기능, 간기능 및 신기능을 가진 환자가 대상 환자로 선정되었으며, 이전에 빈카알칼로이드(vinca alkaloid), 카페시타빈(capecitabine), 젬시타빈(gemcitabine), 파클리탁셀(paclitaxel), 또는 도세탁셀(docetaxel)의 치료를 받은 적이 있는 환자는 제외되었음. 단, 이전에 치료받은 선행화학요법 또는 수술후보조요법이 전이성 질병으로 진단받기 최소 6개월 전에 완료된 경우 및 초기 또는 진행된 질병에 대한 이전의 내분비요법은 허용되었음.
- 33) 약물 투여주기의 중앙값은 신청품군(VNR+CAP)에서 6주기(범위 1-37), 대조군1(GEM+PAC)에서 6주기(범위 1-12), 대조군2(GEM+DCT)에서 7주기(범위 1-25)이었음.
- 34) 대한암학회(), 대한항암요법연구회(), 대한중양내과학회(), 대한폐암학회(), 한국유방암학회()
- 35) 신청품은 기존 계열의 약제로 국민건강보험 요양급여의 기준에 관한 규칙 제11조의2 제1항 제4호 및 약제의 결정 및 조정 기준 제7조제7항에 따라, 약가협상생략기준금액은 대체약제의 가중평균금액(신청약제의 단위 비용으로 환산된 금액)의 90% 금액임.
- 36) 신약 등 협상 대상 약제의 세부평가기준 > 1.3. 비용 효과성 평가기준 > 1.3.1. 지침에 따른 경제성 평가

☐ 경제성 평가 자료의 제출

☐ 비용최소화 분석(Cost-minimization analysis)

- 신청약이 비교약제와 임상적 유용성이 동등(혹은 비열등)하다는 것을 입증할 경우

☐ 임상적 유용성 개선의 판단기준

※ 개선 또는 비열등은 임상적으로 의미있는 지표로 통계적 유의성 또는 비열등성을 입증한 것을 의미함

37) 통계 자문 결과보고(), 통계 자문 결과보고()

38) 동 재정소요금액은 요양급여비용의 총액임(보험자 및 환자 부담금의 합)

39) 제약사 제시 예상 사용량

	1차년도	2차년도	3차년도
나벨빈연질캡슐 20mg			
나벨빈연질캡슐 30mg			

40) 절대재정 소요금액 = 제약사 제출 예상 사용량 × 신청 약가

41) 재정증감액 = 제약사 제출 예상 사용량 × {(신청약가)-(대체약제의 가중평균가)}

42) 제약사 제시 예상 사용량

	1차년도	2차년도	3차년도
나벨빈연질캡슐 20mg			
나벨빈연질캡슐 30mg			

43) 절대재정 소요금액 = 제약사 제출 예상 사용량 × 신청 약가

44) 재정증감액 = 제약사 제출 예상 사용량 × {(신청약가)-(대체약제의 가중평균가)}